

L'examen mental

DR BOUOUDEN

MODULE DE PSYCHOLOGIE MÉDICALE

UNIVERSITÉ DE CONSTANTINE

1- Identité :

*Nom *Prénom * Age * Fratrie *Originaire de * demeurant
à *Etat civil *Niveau socio-économique* Profession *Niveau
de scolarité.

2- Motif d'hospitalisation

3- ATCD : a-Personnels :

- Médicaux
- Chirurgicaux
- Psychiatriques : hospitalisations antérieures

et suivi

- Habitudes toxiques : quantité et durée
- Gynéco-obstétricaux : si femme
- Juridiques

b- Familiaux :

4- Biographie (Recueillie auprès de ...)

a- Grossesse et naissance :

b-Développement psychomoteur :

c-Vie scolaire

d- Puberté et scolarité : Age de la puberté ,ami(e)•

e-Vie professionnelle

f- Personnalité du malade et entourage socio-économique:

- . Relations avec les parents et les frères.
- . Nombre d'amis.
- . Capacité de maintenir des relations stables.
- . Intelligence.
- . Hygiène corporelle et vestimentaire.
- . Faculté d'adaptation aux changements de lieux (voyages).
- . Réaction aux contraintes.

5- Histoire de la maladie :

- . Début
- . Facteurs déclenchant
- . Chronologie
- . Evolution de l'état actuel.

6- Examen psychiatrique :

1- Présentation :

1-Tenue : inadaptée :

- *Excentrique (hystérique) ;
- *Négligé sales (confusion, démence).
- *Clownesque, choquante (accès maniaque).
- *bizarre : schizophrénie.

2-mimique : traduit le langage non verbal exprimé par la face.

- *Hypermimie : euphorie .
- *Hypomimie ou amimie :douleurs morale et ralentissement psychomoteur.

*Dysmimie : c'est la survenue d'une mimique n'ayant aucun rapport avec le discours ou l'affect exprimé.

3-comportement : *Agitation ; stupeur ; Catalepsie ; Para kinésies

2-Contact :

- C'est l'analyse de la relation entre le médecin et le patient.

***Syntone, hyper syntone** : contact facile, voir familial.

***Réticence** : c'est le refus volontaire de parler librement de ce que lui préoccupe principalement.

***Absence** : le sujet n'est pas attentif à l'entretien.

3-conduites instinctuelles :

1 -Alimentation :

***Anorexie, refus alimentaire** :

. L'anorexie: se définit par la diminution ou la perte de l'appétit, qui peut être volontaire ou non.

***Excès alimentaires** :

***Conduites alimentaires aberrantes** :

+pica

2-Sommeil :

***Insomnie :**

+initiale, matinale, totale,

+ L'inversion du rythme circadien

***hypersomnie**

3-Conduites sexuelles :

+Déviations sexuelles : -homosexualité,
pédophilie

+anomalies des fonctions sexuelles frigidité,
impuissance.

4-Conduites sphinctériennes : les pertes

sphinctériennes : sont rares dans les troubles
psychiatriques.

4-conduites sociales :

1-le suicide.

2- Fugues : est l'abandon du domicile ou du lieu
de travail sans but précis.

3- vols pathologiques : exemple : **kleptomanie** :
impossibilité de résister à l'impulsion de voler des
objets qui ne sont dérober ni pour un usage
personnel ni pour leur valeur commerciale.

4-Pyromanie : allumage délibéré et réfléchi d'incendies survenant à plusieurs reprises.

5-homicide : rares.

6 -les attentats aux mœurs : (viol, inceste....).

5-Conduites addictives

Ensemble de comportements visant au recours répété à une drogue ou à un comportement hédonique au détriment d'autres activités.

-alcoolisme

-toxicomanie.

-addiction à l'internet.

6-Fonctions supérieures:

1-Langage : Tachyphémie : la logorrhées ,
Bradyphémie ,rupture brutale (barrage
idéique) ou progressive (fading mental) du
discours ,Mutisme ,Stéréotypie verbale,
néologisme , Aphasies

2-Fonctions mnésiques :

Amnésie :

.Amnésie de fixation (amnésie antérograde)

.Amnésie d'évocation (amnésie rétrograde)

Hypermnésies

3-fonctionnement de la pensée et du jugement :

a-Troubles du cours de la pensée :

+Tachypsychie :

+Bradypsychie

b-Trouble du contenu de la pensée : +idée fixe +idée obsédante +idée délirante +idée dépressive

C-distorsion globale de la pensée :

+autistique +magique +paralogique
+Rationalisme morbide

d- Evaluation globale de l'intelligence :

+trouble du jugement par carence intellectuelle :

4-Activités perceptives :

a-hallucinations : +hallucination psycho-sensorielle, hallucination psychique.

b-Syndrome d'automatisme mental

5-Conscience de soi et de l'environnement :

***Trouble de la vigilance :** les états compris entre une vigilance normale et coma :

-Obnubilation -Hébétude-Confusion-
Coma.

*Troubles de l'attention :

*Troubles de la conscience de soi :

+Trouble du schéma corporel : membre fantôme : c'est une sensation de persistance du membre après son ablation ou son amputation.

+Dépersonnalisation : être détaché de soi.

+ Déréalisation : sentiment d'irréalité et d'étrangeté du monde extérieur

6-Etats émotionnels :

*trouble de l'humeur :

+dépressive

+expansive

+athymique : absence de toute affect.

*troubles anxieux

7-Examen physique

β Constantes hémodynamiques

β Cardiovasculaire

β Pulmonaire

β Neurologique

Et autres appareils selon les signes d'appel.

8-Les examens complémentaires : En

fonction de l'orientation cliniques et des signes d'appels on demande des examens complémentaires radiologiques, biologiques et psychologiques correspondants. Cependant, certains examens sont considérés comme systématiques :

- - la glycémie,
- -ionogramme sanguin.
- -bilan rénal: urée, créatinine sanguine.
- -Bilan hépatique
- -bilan thyroïdien.
- -FNS,
- - ECG, EEG,
- -test de grossesse,
- -les tests psychologiques notamment test de personnalité et les tests d'efficiency intellectuelle.

9-Regroupement syndromique

10-Discussion diagnostique

11-Conduite à tenir

12-Évolution : sur le plan comportemental, cognitif, affectif, instinctuel et physique.

13-Surveillance : constantes++ (pouls, FR, température) ; ECG ; état de conscience ; transit et miction, alimentation et sommeil, imprégnation neuroleptique.

14- Pronostic dépend de :

- La réponse au traitement, de la conscience de la maladie, de l'adhérence thérapeutique et du bon support socio familial.